

Néovessie orthotopique

Information pour le patient · Une nouvelle vessie fabriquée à partir de l'intestin, par laquelle vous urinez naturellement

WARWIKI

La néovessie orthotopique est une nouvelle vessie fabriquée à partir d'un segment de votre propre intestin et reliée à votre urètre, afin que vous puissiez uriner normalement — sans poche — après l'ablation ou la défaillance de la vessie. Il faut du temps et de la pratique pour bien la vider et retrouver le contrôle.

À propos de cette chirurgie

Environ **40–60 cm d'intestin grêle** sont ouverts et repliés en un réservoir à basse pression, puis reliés à votre **urètre** ; les uretères (tubes des reins) y sont branchés. **Pas de stomie ni de poche.**

Comme la néovessie est faite d'intestin, elle ne donne **pas** la sensation habituelle d'envie d'uriner. Vous apprendrez à :

- Vider selon un **horaire fixe** — en relâchant le plancher pelvien et en poussant doucement — y compris **la nuit**.
- Utiliser une sonde pour vider la néovessie si elle ne se vide pas complètement (plus fréquent chez la femme).
- Pratiquer des **exercices du plancher pelvien** pour renforcer le contrôle.

Le contrôle s'améliore sur **plusieurs mois** ; des fuites, surtout nocturnes, sont fréquentes au début. Cette technique ne convient pas à tous — cela dépend de votre urètre, de la fonction rénale et de votre capacité à suivre la routine.

Est-ce sans danger ?

C'est une option bien établie offrant le résultat le plus « naturel ». L'opération est plus longue qu'un conduit iléal et demande plus d'apprentissage et de suivi. Risques : complications chirurgicales (saignement, infection, fistule), fuites diurnes ou nocturnes, vidange incomplète nécessitant l'auto-sondage, mucus, infections urinaires, et modifications à long terme des sels/vitamines/reins surveillées en consultation.

COMPRENDRE LES TERMES

Néovessie

Nouvelle vessie fabriquée à partir d'un segment d'intestin.

Orthotopique

Placée à l'emplacement normal et reliée à l'urètre, pour uriner naturellement.

Urètre

Canal par lequel l'urine quitte le corps.

Uretères

Tubes qui transportent l'urine des reins vers la néovessie.

Mictions programmées

Uriner selon un horaire fixe (jour et nuit) sans attendre l'envie.

Auto-sondage

Introduire soi-même une fine sonde pour vider complètement la néovessie si nécessaire.

Plancher pelvien

Muscles entraînés pour retenir et libérer l'urine.

Mucus

Liquide sécrété par l'intestin ; des filaments dans l'urine sont normaux.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La chirurgie se fait sous anesthésie générale : vous ne sentez rien. Ensuite, l'abdomen est douloureux et l'intestin met quelques jours à « se réveiller ». Vous aurez une sonde dans la néovessie (environ 2–3 semaines) et de petites attelles souples. L'hospitalisation dure 5–8 jours ; l'opération est longue.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Sous **anesthésie générale** — respectez toutes les consignes (jeûne, arrêt des anticoagulants selon prescription). Une **préparation intestinale** peut être requise.
- Comprenez l'engagement : **mictions programmées jour et nuit**, possible **auto-sondage** et exercices du plancher pelvien.
- **Ne fumez pas** et organisez une aide à domicile pour la récupération.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection en cours
- Avez une **maladie intestinale**, des problèmes rénaux, ou des antécédents de chirurgie ou radiothérapie abdominale

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi sous anesthésie ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 Un segment d'intestin est prélevé ; le reste de l'intestin est reconnecté.
- 3 Le segment est ouvert et replié en réservoir, puis suturé à l'urètre.
- 4 Les uretères sont branchés sur le réservoir ; une sonde et des attelles souples sont mises en place le temps de la cicatrisation.

Après la chirurgie

- Retour à domicile en **5–8 jours** avec une **sonde ~2–3 semaines** ; vous pourrez l'irriguer pour éliminer le mucus. Une **radio de contrôle** précède le retrait de la sonde.
- Vous apprendrez ensuite les **mictions programmées** (réveil nocturne), les exercices du plancher pelvien et l'**auto-sondage** si la vidange est incomplète.
- Des **fuites initiales** (surtout nocturnes) s'améliorent en quelques mois. Le mucus est normal ; buvez assez ; suivi à vie (dont vitamine B12).

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- **Impossibilité d'uriner** ou sonde qui **ne draine plus**
- Douleur abdominale intense, vomissements ou **absence de gaz ou de selles**
- Saignement abondant, rougeur ou écoulement de la plaie, ou douleur lombaire

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La néovessie est une nouvelle vessie faite d'intestin et reliée à l'urètre, permettant d'uriner naturellement sans poche.
2. Elle demande de la pratique : mictions programmées jour et nuit, exercices du plancher pelvien, et parfois auto-sondage. Le contrôle s'améliore progressivement.
3. Respectez le jeûne et la préparation intestinale, et ne fumez pas. Gardez la sonde jusqu'à son retrait par votre équipe après la radio de contrôle.